Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Gravatá

R QUINTINO BOCAIÚVA, S/N, - de 274/275 ao fim, QUINZE DE NOVEMBRO, GRAVATÁ - PE - CEP: 55641-670 - F:(81) 35339899

Processo nº 0004009-32.2022.8.17.2670

AUTOR: GILVANETE MARIA DE AMORIM SILVA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO

Cuida-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** ajuizada pela PARTE AUTORA, acima identificada, em face do ESTADO DE PERNAMBUCO, em que busca o fornecimento do medicamento **Daratumumabe e Lenalidomida**, alegando, em síntese, que "*A Autora é portadora de MIELOMA MÚLTIPLO CID - C90.0, consoante laudo médico em anexo. Mesmo após dois transplantes de medula, comparece em consulta referindo dores ósseas em dorso de forte intensidade mesmo com uso de morfina oral. Devido aos inúmeros tratamentos realizados, 2 transplantes 1 auto e 1 alo, não tem mais opções a nível SUS. Necessita do fornecimento de Daratumumabe e Lenalidomida para tratamento de recaída em 5º linha. Paciente com doença agressiva em risco de progressão e óbito.*"

Narra que "*Em razão disso, foi-lhe receitada a seguinte medicação: 16 FA - DARATUMUMABE 400mg - 2 Ampolas + SF0,9% 1000ML - IV Lento 1 vez por semana total de 8 doses, depois quinzenal por mais 8 doses e por fim a cada 4 semanas, além de 2cxs de LENALIDOMIDA 25mg - Tomar 1 comprimido ao dia por 21 dias, descansar 1 semana e reiniciar, consoante receituário médico. Medicação de tratamento por tempo indeterminado.*"

Afirma que se trata de medicamento de alto custo, pois o custo aproximado do tratamento com as duas medicações é de R$ 208.920,00 (duzentos e oito mil novecentos e vinte reais), ressaltando que a autora é pessoa hipossuficiente.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi colhida a Nota técnica do e-NATJUS, ID 114132239.

Manifestação prévia do Estado pugnando pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada – ID 114269999.

Contestação – ID 114775091 – sustentando, preliminarmente, a aplicação da tese firmada no TEMA 793 pelo STF, requerendo, assim, a inclusão da União Federal no polo passivo do presente feito, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, e a incorreção do valor da causa. No mérito, em síntese, defendeu que fosse considerada a análise pela CONITEC que não recomendou a incorporação no âmbito do SUS, haja vista, o elevado impacto

orçamentário; a existência de políticas públicas e o laudo médico não justifica a utilização destes medicamentos em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS, requerendo a improcedência dos pedidos, apresentando pedido subsidiário no caso de procedência.

Réplica – ID 114979508.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, haja vista que não há necessidade de produção de prova oral ou pericial, uma vez que os documentos acostados são suficientes à formação da convicção do juízo quanto aos fatos.

Pretende a parte autora o provimento jurisdicional no sentido de impor ao Estado de Pernambuco a obrigatoriedade do fornecimento dos medicamentos **DARATUMUMABE 400mg e LENALIDOMIDA 25mg**.

DAS PRELIMINARES

Em relação à preliminar de inclusão da União e consequente remessa para Justiça Federal entendo que **não merece acolhimento**.

O pedido sob cogitação encontra base constitucional, ante o disposto no art. 196 da CF/88, adiante transcrito:

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Esse dispositivo estabelece que é dever constitucional do Estado (em sentido lato) prover a saúde pública de maneira universal e igualitária, colocando em prática medidas que assegurem a prevenção e recuperação dos males causados pelas doenças. E ao dispor nesse sentido, a Constituição da República refere-se ao dever do Poder Público, abrangendo, todos os entes públicos, inclusive Estados e Municípios.

Assim, sendo a saúde um direito subjetivo público individual, impõe-se ao Estado, como um todo, o fornecimento de prestações positivas em favor do indivíduo portador de uma enfermidade, independentemente de qualquer contrapartida ou comprovação de contribuição do beneficiário direto.

E para implementação de ações visando assegurar esse direito, a Lei nº 8.080/90 estabeleceu a participação das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) no planejamento, na programação e na organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em regime de **responsabilidade solidária.**

O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida em sede de Embargos de Declaração ao sobredito Recurso Extraordinário nº 855.178, **reafirmando a tese de responsabilidade solidária** dos entes federativos no fornecimento de medicamentos (STA 175), fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"**.**

Nesse ponto, impende destacar que, recentemente, em 29/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela <u>desnecessidade de inclusão da União</u>, esclarecendo que "em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, <u>ainda que não incorporado</u> em atos normativos do SUS, <u>descabida a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda</u>". GRIFEI

Vale a pena consignar parte do voto da Relatora Ministra Assusete Magalhães nos autos do RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 68.602 – GO:

> "Recentemente, a Primeira Seção do STJ deixou de exercer juízo de retratação, em face do decidido pelo STF, nos Embargos de Declaração no RE 855.176/SE (Tema 793), aos seguintes fundamentos, sumariados na ementa do acórdão:
>
> "PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
>
> 1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos.
>
> 2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envol medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.
>
> 3. Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.'
>
> **4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), <u>não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.</u>**
>
> **5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão – repita-se – não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.**
>
> 6. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, **relaciona-se ao cumprimento de sentença** e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
>
> 7. Por fim, cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o

saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

8. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

9. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva e **levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual** para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

10. Juízo de retratação rejeitado" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022)

Nessa senda, AFASTO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.

De igual sorte, a alegada incorreção do valor da causa, em que a parte ré busca o estabelecimento do valor da causa em quantia simbólica de R$ 1.000,00 (mil reais), sob o argumento de que se trata de conteúdo econômico inestimável, também não merece guarida.

Isso porque, mesmo nas causas de direito de saúde, o valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido na demanda, o qual nos pedidos de fornecimento de medicamentos, que são prestações vincendas, deve corresponder a uma prestação anual, conforme art. 292, § 2º do NCPC.

No caso em apreço, segundo a inicial, cada frasco da medicação DARATUMUMABE 400mg custa o valor de R$ 9.445,00 (nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), precisando a autora de 16 frascos, perfazendo o valor total de R$ 151.120,00 (cento e cinquenta e um mil cento e vinte reais).

Outrossim, uma caixa da medicação LENALIDOMIDA 25mg custa o valor de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais), necessitando a autora de 2 caixas, perfazendo o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais).

Nessa senda, tenho que o valor da causa de R$ 208.920,00 (duzentos e oito mil novecentos e vinte reais) atribuído pela parte autora corresponde ao valor aproximado do tratamento, **pelo que rejeito a referida preliminar**.

NO MÉRITO

É cediço que, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 106), o STJ firmou tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.

No caso dos autos, os laudos médicos – ID 113606308/ 114979528 comprovam que a parte autora padece Mieloma Múltiplo CIDX – C90.0, bem como a necessidade e urgência dos medicamentos perseguidos, visto que, após dois transplantes de medulas, já utilizou, mais de uma vez, todas as drogas disponíveis no SUS, sem sucesso.

Há evidências científicas. A nota técnica do NATS revela: "Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Aumento da sobrevida livre de progressão de doença".

É incontroverso que se trata de medicamentos de alto custo e que a parte autora é hipossuficiente.

Além disso, os fármacos estão devidamente registrados na ANVISA (ID 114132239).

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que estão preenchidos os três requisitos erigidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106 dos recursos especiais repetitivos, de sorte que concluo pela existência do direito ao fornecimento dos referidos medicamentos, bem como está presente o perigo na demora, pois a negativa da tutela implicaria o agravamento do quadro de saúde do(a) autor(a), sendo o deferimento da tutela antecipada medida que se impõe.

Por oportuno, cabe destacar que o alto custo do medicamento não impede a decisão judicial.

Nesse sentido, assim decidiu o E. STF no julgamento do RE nº 566.471, ainda pendente de publicação do acórdão, no qual o Min. Rel. Marco Aurélio, pugnou pela fixação da seguinte tese no Tema nº 006 da repercussão geral: "O reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade adequação e necessidade , da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil".

Além disso, em que pese o fato de que o medicamento postulado pelo autor não se encontra padronizado pelo SUS, não pode o requerente ser prejudicado pela administração de fármaco diverso daquele prescrito pelo médico que o acompanha.

É o que preconiza o enunciado cristalizado na **Súmula n° 18 do Egrégio TJPE, que estabelece o seguinte:**

"É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, **ainda que não previsto em lista oficial**." Grifei

Quanto à eventual redirecionamento/ressarcimento, entendo que cabe ao Estado, em ação própria, veicular tal pretensão contra a União, visando ao ressarcimento dos valores gastos pelo Estado para disponibilizar o tratamento objeto da presente demanda.

Friso que a tese fixada no TEMA 793 não afasta a responsabilidade solidária, mas apenas aponta que, caso a Fazenda Estadual entenda que a prestação é de responsabilidade da União, em razão de critérios de hierarquização e descentralização, compete à mesma exigir futuramente a compensação financeira, de forma administrativa ou por meio de ação de regresso

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, **CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA**, ao passo em que **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, e, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando que o réu forneça, **no prazo de 10 (dez) dias úteis**, o(s) medicamento(s) na forma prescrita pelo médico, a saber: 16 FA - DARATUMUMABE 400mg e 2cxs de LENALIDOMIDA 25mg, pelo período de **03 (três) meses**, **renováveis, mediante a apresentação de laudo médico atualizado**.

No caso de descumprimento, fixo **multa diária**, de **R$ 1.000,00 (mil reais),** em favor do(a) autor(a), levando-se em consideração o valor aproximado dos medicamentos.

Sem custas, visto que o credor e o devedor são a mesma pessoa (o Estado).

Sem honorários, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Sem remessa necessária porque se trata de obrigação de fazer.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Havendo apelação, intime-se o apelado para as contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, subam os autos à superior instância.

Transitada em julgado, arquive-se.

GRAVATÁ, 10 de novembro de 2022

Juiz(a) de Direito

JJCR

Assinado eletronicamente por: LUIS VITAL DO CARMO FILHO
11/11/2022 02:22:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 119483929

22111102221946600000116794184

IMPRIMIR GERAR PDF